Časová naléhavost: RUTINA *Objednal:* Operační sál

Laboratorní vyšetření

Ze dne:

Pacient 3

Dat. nar.: *Č. poj.:* **323456/3333**

Bydliště: *Kód poj.:*

Histologie

B_AA Lokalizace 6 Text...

B_AA Lokalizace 6

PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE BIOPTICKÉHO MATERIÁLU

Vyšetřovací číslo:
Datum odběru:2 Datum příjmu:2 Datum odeslání:
Žadatel vyšetření:
Klinická diagnóza:C321
TOPOGRAFIE ODBĚRU: 6/6 resekát hrtanu
KLIN. DIAG.:
prosím o histo rozbor, pacient se spinocelulárním karcinomem pravé glotis cT4aN0M0, provedena totoální laryngektomie a BND obouzstranně II-V, vpravo zvětšené soutokové uzliny v regio II, a kulovité v regio III vpravo, vlevo blok bez makroskopicky susp. LU, děkuji

DIAGNÓZA: C321
CHIRURGICKÉ VYŠ.:

NÁLEZ:
6/6
3592/2026
Makropopis:
V nádobě označené "histologie 6. hrtan" zaslán resekát hrtanu bez nastřižení celkové hmotnosti 58,9 g a velikosti 7,5 x 4,5 x 4 cm. Po rozstřižení je v oblasti vestibulum laryngis na pravé straně zastiženo ložisko, velikosti 2,5 x 1,8 x 0,4 cm, na řezu solidně utvářené, bělavé barvy, pevně lnoucí ke štítné chrupavce a které je vzdálené od kaudální resekční plochy 1,8 cm. Pravou polovinu barvím černou tuší, levou polovinu barvím modrou tuší.
Epiglottis velikosti 3,5 x 3,5 x 0,1 cm, elastické konzistence, žlutofialové barvy, kraniálně nad ložiskem ve vzdálenosti 0,3 cm necelistvá, potrhaná.
Štítná chrupavka velmi tvrdé konzistence, po odpreparování měkkých struktur od pravé poloviny, vkládám tuto pravou polovinu do odvápňovacího roztoku.
27. 2. 2026 Po vyjmutí z odvápňovacího roztoku byly doblokovány bločky od k po c1.

Blokována rezerva RA-I/2026
Sam

Mikropopis:
(6/6 resekát hranu)
a-c1, Ra-Ri/ V zaslaném extenzivně zpracovaném po vložení do odvápňovacího roztoku materiálu zatíženy průřezy strukturami laryngu, kde v četných blocích jsou patrny těžké dysplastické změny sliznice, přecházející v rozsáhlé, povrchově ulcerované, zčásti exofyticky utvářené ložisko středně diferencovaného dlaždicobuněčného (spinocelulárního) karcinomu s patrnou zachovalou, místy objemnou extra- i intracelulární polycelulární keratinizací. V okolí nádorových čepů s nálezem výrazné stromální desmoplazie, s hojnější smíšenou zánětlivou celulizací, místy také s granulomatózní reakcí typu kol cizích těles. V IHC průkazu jsou nádorové elementy s patrnou expresí CK a p53 (aberantní), s negativitou v průkazu p16. Proliferační aktivita dle Ki67 činí průměrně 45 %.

Charakter růstu odpovídá WPOI 4. stupně, TB 3. stupně (HG, vysoké intenzity, fokálně 19 buddů / 20x PF). Nádorové elementy rozsáhle infiltrují měkké tkáně laryngu a rovněž ve vícero blocích prorůstají do osifikované štítné chrupavky, přes kterou nepřekračují, maximální hloubka invaze činí nejméně 12,09 mm. Zde jsou nádorové elementy nejblíž černou tuší nabarvené resekční plochy, kterou však neporušují, minimální vzdálenost činí 0,27 mm. Struktury epiglottis a kaudální resekční okraj s patrnými průřezy strukturami trachey bez nádoru. Na preparátech se zastižením vícečetné lymfovaskulární invaze, bez jednoznačně patrných známek perineurálního šíření. Rovněž zastiženy průřezy 1 lymfatickou uzlinou a okrskem parenchymu štítné žlázy bez nálezu nádorové infiltrace. Povrchově s nálezem objemnějších kolonií mikroorganismů. Materiál opakovaně prokrojen a extenzivně doblokován.

Závěr:
1. dlaždicobuněčný (spinocelulární) karcinom
2. p16 status - negativní
3. grade 2, středně diferencovaný
4. WPOI - 4. stupně
5. TB - 3. stupně, vysoké intenzity (19 buddů)
6. lymfovaskulární invaze - ano
7. perineurální šíření - ne
8. okraje - negativní
9. velikost tumoru - 25 x 18 x 4 mm (měřeno makroskopicky)
10. vyšetření uzlin - 59/0 (58/0 + 1/0 v rámci hlavního resekátu; vizte také biopsie č. 3587-3589/2026)
11. pTNM staging - pT3N0Mx

Val

M1:	M80703	KARCINOM DLAZDICOVY	G:2	P:1
M2:	M80772	LEZE INTRAEPIT.SKVAMOZNI HIGH GRADE	G:	P:1
M3:			G:	P:
TOP:	T2410	HRTAN NS		